호흡기내과 메인 인계 정돈본 v9

사용자 정리본을 바탕으로 다시 쓴 설명 + 조사 보강만 남긴 버전

인계 원문 제거 / 논리 구조 중심 재정돈

source_title
D호흡기 내과 인수인계 – 업데이트 날짜 26.03.28

의국
내과 의국 : 혈종 옆

의국_비번
의국 비번 : 0706 – 학생한테는 안 알려줄거라고 하셨음. 일단 모른척 ㄱ

의국_wifi
의국 wifi : 06070607

외래
외래 : 암센터 가는 길 바로 앞, 신장내과 옆 (투썸쪽 2층)

핵심 과제 요약

과제	마감	형식	우선도
임상윤리수업	교수님께 제출일정 확정 받음(2주차 주말까지)	수업 내용 및 느낀점 A4 한장 정도로 쓰기	중
PFT, SPT	마지막 날 자정(2주차 금요일)	수업 내용 및 본인 PFT, SPT 결과 분석하는 레포트	상
중환자실 케이스	발표 전날 자정에 제출했고, 발표 후 교수님께 말씀드리고 수정본 다시 올림.	케이스 발표 자료/수정본 업로드	상
알레르기 질환 케이스	교수님께 제출일정 확정 받음(2주차 주말)	skin to prick test한 팔과 본인 명찰 나오게 사진 찍어서 분석하기	상
실습 면담 평행차트 (word 첨부)	교수님께 제출일정 확정 받음(수업 당일 자정)	수업 전에 미리 써감	중
임상추론평가	2주차 금요일 자정. 화요일까지 제출할 필요는 없음.	임추평 피드백 때까지 웬만하면 작성, 발표자 1명은 반드시 다 써가기	상
예진 평가(기존 CP 포트폴리오 대체)	첫번째 포트폴리오는 수업 직전까지, 나머지는 2주차 금요일 자정	첫 피드백 때 적어도 하나씩 프린트, 환자 겹치지 않게	최상
병동 경과기록지 (주당 3개)	피드백 전날까지 제출	2p 정도로 조원들 모두 통일, 파일 안에 학번/이름 포함	최상
외래 예진 (2개)	마지막날 자정. 피드백3과 함께 (P/F임)	PDF로 제출함 / 당일 오후 6시까지 의국 제출 후 스캔 업로드	최상
CXR 과제	없음	정제욱 교수님 발표자료만 이메일 제출	낮음
기관지내시경 참관 (word 첨부)	최신 공지 재확인	참관한 case 정보만 써서 제출	중
Mini CEX	클레스몰이나 교수님 언급도 없음	아무도 제출 안했다	확인필요
폐진찰 피드백	당일까지 제출	피드백2 종이 스캔해서 pdf 제출	상

제출 공통 메모

- Classroom에 모든 과제에 대한 설명이 자세히 나와있으니, 과제 작성 전 꼭 참고할것.
- 수업 시간 때도 교수님께 언제까지 제출할지 다시 여쭤보자.
- 과제는 classroom에 구글 docs로 제출하자. 워드에 적었다가 구글 docs에 복붙해도 된다. (표절 검사 때문에 그렇다고 함) 공지에 따로 얘기 없으나 모두 docs로 제출 (평행차트, 기관지내시경 – 워드 첨부)

외래 교수님 추천표

상	김덕기, 홍그린, 우성대, 김소윤
중	정성수, 박희선
하	정제욱, 이정은

1주차

원문을 빼고, 정돈된 설명과 조사 보강만 남김

월요일

OT는 병동기록지 환자 배정 + 질문번호 + 원가변수 설명을 듣는 운영 세팅 시간
병동정리기록지는 1주차 3일 + 2주차 3일, 주차당 1명 환자
기록지는 SOAP 흐름과 강사 의견 설명이 핵심
PFT는 회요일 수업을 결과지 확보 목적
결핵/NTM은 본강 강의를 기반 중 강의나 예습 흐름이 좋음

8:50 실습 오리엔테이션 및 환자 배정 — 교수님 확인

OT는 그냥 규칙 소개 시간이 아니라, 질으조 2주 동안 병동기록지 예진·질문번호를 어떻게 골랐지 정하는 운영 세팅 시간이다. 지금 기준에서는 CP보다 병동정리기록지에 예진 목 운영을 이해하는 것이 더 중요하다.
OT / 환자배정 / 운영 브리핑

핵심 정리
- 병동과제 기록지 작성법 환자별 배정해주신다.
- 연관된 실習에 대한 질문문 받기가 어렵게 이루어지는지 설명해주신다.
- 병동 기록지는 총 6일(1주차 3일 + 2주차 3일), 주차당 1명씩 배정된다.
- 1주차 환자는 월요일 뵈게, 2주차 환자는 1주차 금요일에 배정된다.
- 회요 SOAP 중심으로 기록하고, 월요일부터 서 세 환자를 교체한다.

- 내가 CEX나 EMR로 뽑기한 환자를 병기하면 교수님께 어떡드리고 바로 수 있다. (예정, 경력, 흉진해등, 고정 제외)
- 병동정리기록지는 주차당 1명씩 총 2명의 환자를 맡아 6일간 SOAP를 쓴다. 구조로 이해하면 된다.
- 환자 배정은 질문으로 순번 뽑혀 총 두 명으로 확정되고 한 명은 월요일 오전에 첫 얼굴 마주치는 것은 아니다.
- 월요일 이후 본격적으로 OT 세션 일정은 면접 때 제출 양식 안내에 있다.
- 월요일 이후부턴 환자 정기 미팅이었고 1주차에는 1인 시간에는 제주는 한학자 필요는 없음.

준비 / 운영 포인트
- 다가올 병동기록지 환자 배정 타이밍 확인.
- 해진을 인해하지 않아도 자율이 조 내부 간격 세우기
- 질문 번호 시 누구를 적절 어떤방식 확인.
- 환자 연관 가능 조건과 금지 케이스(예진, 경력, 흉진해등, 고정) 기억하기

10:30~12:30 환자 문진 신체검사 증과기록지 작성법 — 김덕기 교수님

이 시간은 결국 양식을 잘라주는 시간이라기보다, 병동기록지를 성상주론 문서처럼 쓰라는 기준을 심어주는 시간이다. 특히 Assessment는 S/O를 근거로 차근스럽게 이어져야 하고, 검사도 결과만 적는 게 아니라 왜 했는지 설명할 수 있어야 한다.
병동기록지 보는 법

핵심 정리
- 정상에는 의학에서 조진 환자 되도록 하고 초진일 기준으로 작성한다.
- 환자의 호소 증상이 어떤 과정이 시작해 때해 지세하게 간별해야 한다.
- 환자 단락은 문단 단위일과 서해서 논리 흐름이 느끼어야 가장해야 한다.
- 각 섹션을 왜 쓰는지 논리적으로 설명할 수 있어야 한다.
- 왜 이 질고에를 고민하는지 주서나 그냥 기준으로 적어야만 한다.
- 정 기록은 상황 후 정 정리하장 자세히 한다.
- 증상이 어떤 경향 하나만 적지 말고 시간의 경향 흐름을 보기해야 한다.
- 교수님이 나눠주시는 질 은 예시가 사실상 정답지 역할을 한다.

시간 변동 폐기능실 참관 — 교수님 확인

이건 특강적인 배동의 시간이라기보다, 회요일 흐름기계 검사 강의 전에 분인 PFT 결과지를 확보해두는 실무 일정이다.
회요일 수업용 PFT 사진 준비

핵심 정리
- 폐기능검사지를 가지기이 해서 미리 하는 것이다.
- 보통 5일 오후 5시~5시반경 시행한다.

준비 / 운영 포인트
- 강의 기전 인전 폐기능검사실에서 시간 조율
- 지금 바쁘는 것을 강조드 없음
- 시간표상이 수요일 폐기능실 일정은 일요일 선시행으로 사라질 수 있음

시간 변동 결핵, NTM 강의 — 김옥희 교수님

결핵/NTM 강의는 전체 흐름기 일정 중에서는 비교적 편한 중 강의 쪽이다. 본강 강의에과 많이 겹치고, 질문도 그 범위 안에서 나오는 편이라 예습 효율이 좋다.

핵심 정리
- 강의용 교수님은 하니고, 본강 강의를과 거의 유일하다.
- 질문은 조금 정리해 가면 좋지만.

준비 / 운영 포인트
- 강의에서 중요해 보는 흐름
- 정독강해로 간 내는는 관문가 있었다.
- 마지막에 환자를 질은 1~2개 정도 준비하면 무난

화요일

CXR은 한날명 질문답변 수업 위주이 강하고, 다음 발표 준비 규칙을 잡는 시간
정독화 교수님 카민민 개인당 case 3개 deck으로 보는 것이 현재 가장 안전
흐름기계 강의 강의는 짧고, 배표르는 내용보다 적용 여부가 더 중요
중환자실 참관은 ICU 케이스 발표용 환자 배정이 핵심
배진항진 PFT자진 설계표는 실기 교정 수업이라 따라하진 디테일 연습이 중요

9:00 ~ 10:00 CXR 판독 — 정재욱 교수님

첫 주 화요일 CXR은 발표 시뮬레이션 오리엔테이션 성격이 강한 질문답변 수업이다. 대신 여기서 다룬 발표의 형식이 메고크드로, 유튜브 강의 내용을 바탕으로 판독 언어를 익혀고 질문에 익숙해지는 것이 핵심이다.
정재욱 교수님 CXR 입문 + 다른 발표 예고

핵심 정리
- 유튜브 링크를 올려주시니 그걸 먼저 공부해가면 된다.
- 비도, 심낭삼, 흉부 사진 판독 정확도, 능숙도를 평가하고 본다.
- 다음주 화요일에서 케이스를 준비해보고 하는데, 몇 개 준비하는지 확인이 필요하다.
- 이미에도 오전과 마찬 가능하다.

준비 / 운영 포인트
- 유튜브 강의 미리 보기
- 이미에도에 판독 실습용 장치
- 대상자 질문 1개 준비
- 다음주 화요일 개인당 3 case 루트 환자 추려기

질문 / 예시 포인트
- 0.0.1 한기요구 : 왜 간질부가 증상이고 왜폐세포인지 진단을가 잘한지는, CXR에서 reticular pattern을 보이는 질환
- NTM은 한쪽간? 자이폐간? 차교 하나요? : 비결핵성 항산균에 의해 생기는 질환. 전염력 없어서 격리 필요 없음 (사람 간 전파를 안함). 배경력은 한단 시 바로 치료하고 NTM은 안함
- 왜 AP를 찍을까요? AP와 PA의 차이점?
- Lateral view에서 어디가 제일 중요한가요?

준비 / 운영 포인트
- 발표 준비 기준: 한째 건 뽑아 기준으로는 정재욱 교수님 라인에서 개인당 case 3개 deck으로 모는 것이 가장 안전하다.
- 2인당 1개 가능는 이야 모 정재욱, 개인당 3 case 한으로 유연 준비하는 게 맞아 보임.
- 파인 이해에 다음주 화요일에서 케이스 3개 준비하고 하게 되음
- CXR 프렌 용어에 익숙했 appt가 지금 요해됨
- 샘플 파일명에 3case가 정시되어 있고 실제 클라이드도 #1 #2 #3 구조임

10:30 ~ 12:30 호흡기계 검사 강의 — 우성대 교수님

호흡기계 검사 강의는 심개 파고드는 수업이라기보다 PFT/ABGA를 한 번 짚고, 본인 검사지를 근거로 짧은 케표드를 내게 하는 일정에 가깝다.
짧은 수업 + 케표드 제출

핵심 정리
- 수업은 30분 정도다.
- 수업 내용 + 본인 폐기능 검사 결과가 어떤지 2주차 금요일까지 케표드 형태로 제출한다.
- 내용보다는 제출하는 것이 중요하니 심플하게 작성하면 된다.

준비 / 운영 포인트
- 본인 PFT 결과지 지참.
- 수업 끝나고 바로 케표드 초안 메모
- 2주차 금요일 제출 마감 확보

13:30~14:30 중환자실 참관, 환자 배정 — 이승이 교수님

이 시간이 핵심은 중환자실 투어가 아니라, 나중에 조 안에서 발표할 MICU 환자를 정하고 발표 방향을 튼는 것이다.
ICU 케이스 발표용 환자 배정

핵심 정리
- 케이스 발표 환자를 배정받는다.
- 질문이 학교에서 어떤 걸 고려해서 발표해야 하는지 잘 정리하는 것이 관건이다.

준비 / 운영 포인트
- 교수님 바로 앞에서 듣는 사람이 여럿을 책임지는 게 중요
- 환자 직후 발표해 설명 대응과 review 수준을 다시 확인하는 게 좋음
- 최신본 케이스(2주차) review를 선택하는는 인계가 있음
- 해월/배랑 환자 중 선택권을 준 조도 있었음

조사 / 보강 내용
- definition: 배정받은 MICU 환자 1명을 조 전체가 준비해서 pulmonary ICU case presentation으로 발표한다.
- sample_ppt_structure: Present Illness; Vital / PMH / medication / labs; Initial chest X-ray; Problem list; Initial Assessment & Plan; ABGA 해석; Ventilator setting / weaning / estubation; Follow-up CXR; Review

15:30 ~ 18:00 폐진찰 사례 및 피드백 — 박희선 교수님

현식은 본인이 실제로 정재욱 환자를 하나씩 고정받는 실기 수업이다. 특히 타진·청진 위치를 같은 level로 맞추는지, 환자에게 옆고 자연스럽게 지시하는지, 양가슴/뒷가슴을 어디까지 보는지 같은 디테일을 많이 본다.
P/F 실기 + 교정 중심 피드백

핵심 정리
- Pass or fail이고 현장에선 pass를 준다.
- 비도백을 왼쪽이 놓주다니 해줘가는 시간이다.
- 환자를 대상을 바꿔 연습하는 것도 가능하다 있다.
- 타진과 청진을 같은 위치에서 한다.
- 상체나 어깨를 level 맞춰 대칭되도록 내려오기
- 환자에게 옆고 자연스럽게 지시하는 것도 중요하다 있다.
- 양가슴과 양등 부위를 번갈아 비교하는 게 중요하다 잘 들리는 위치를 선택하기
- 환자 보는 눈이 아니라 진찰과제 연기
- 피드백 중이를 듣고 기록 연기 후 스탠 제출하기

준비 / 운영 포인트
- 피드백 듣기 준비
- 타진 연습
- 양쪽 비교 위치 연습
- 자율 병노 해진찰 대본 생성 해봄

조사 / 보강 내용
- result: 25 폴더 내 병도 완성형 해진표 대본 파일은 아직 못 찾음
- usable_reference: C:/Users/sjfhk123gmail.com/Desktop/의학과 공부 자료/폐3/폐흉기내과/25/(0) 조정이상/★조정인계/폐진찰 사항 (2주차 수) + 25 병도 인계사항 없습니다. 파일 별 일정 참고.docx
- note: 이 파일명 순서, 위치, 면허 입이 정하지 이상 바탕으로 시험용 대본 참장이 가능함

수요일

외래 예진은 1주차에 최대한 많이 배두는 게 중요
추천 교수님은 김덕기/홍그린/우성대/장소윤
정재욱/이정은 파레는 lung nodule 환자가 많아 추천위
오가노이드는 부담 없는 연구 소개 시간

9:00~10:00 외래 예진 — 교수님 확인

수요일 외래 예진은 그냥 한 술씩이 아니라, 2주 실습 전체 예진 분량을 초반에 확보하는 핵심 시간이다. 실제로는 시간표에 없는 빈 시간에도 예진을 보러 가야 하지만, 수요일 오전이 가장 본격적으로 굴리는 시작점이다.
1주차 예진 몰아보기 핵심 술못

핵심 정리
- 진료에 추천된 교수님 + 김민기 교수님 예진을 챙기 갔다.
- 폐진기록지 2장을 들고 다니다.
- 폐진 시작시간과 종료시간 적어서 따로에 적을한다.
- 폐진 보고 예상 환자 인원 시작할 때 같이 물어가고 옮니면 기면 된다.
- 아침은, 정재욱 교수님 외래는 lung nodule이 많아서 피하는 것이 좋다.
- 우성대 교수님은 인슈 설명보다 환자는 뱉는 게없이 있고 어나할이시스, 일광 부종, 진이 등은 관찰다.
- 생각보다 늦 환자가 많아서 1주차 예정대로 해보면 놓치게 된다.
- 간호조무사 선생님께 물고 대기하면있고 미리 알려고 대기하면 된다.

준비 / 운영 포인트
- 폐진기록지 2장 + 환자보고 개념을 챙기되, 최신 기준으로는 시작/종료시간 기록 후 의국 제출이 핵심
- 간호조무사 선생님께 먼저 물고 대기한다고 말해두면 기회가 생길 수 있음
- 1주차에 많이 해두어 질으은 본인에게 조금 용이한 기억이 있음?
- 심소윤 교수님 기준으로 lung nodule 환자는 생기 보단다가 적어서 전공적으로 피하는 편이 낫다

9:00~10:00 최진 참관 — 정재욱 교수님

이 항목은 현금 보조성 낮기도 하고, 시뮬자 본인(B조) 기준으로는 이번 수요일 핵심 일정이 아니다.
A조에 최진 / 사용자 B조는 참고만

13:30~15:30 폐기능실 참관(우성대 교수님) — 교수님 확인

16:00 -17:00 오가노이드 (정재욱 교수님) — 교수님 확인

오가노이드는 시험성 강의가 아니라 연구 소개/질문 시간에 가깝다. 부담 없이 듣고, 연구 쪽에 관심 있으면 질문해볼 만한 시간이다.
개배운 연구실 소개 시간

핵심 정리
- 교수님 본인이 이니면 비교적 편하게 가면 된다.
- 신이도 참관 느낌이다.

목요일

사실 강의는 기관지내시경/흉수 강의가 합쳐지거나 취소되는 등 변동이 많음
결핵/흉기 수업은 실제로 3개 2개가 생기는 일정
대면 실습 예비이는 지식평가보다 적용과제 중심의 피드백 중심

8:00~10:00 호흡기내과 시술 강의 — 박동일 교수님

핵요일 시술 강의는 그냥 강의라기보다 박동일 교수님 일정에 따라 합쳐지거나 밀리거나 대체 과제로 바뀌기 쉬운 슬롯이다. 그래서 내용 자체보다 일정 변동 대응이 더 중요하다.
기관지내시경 + 흉수 강의, 변동 많음

핵심 정리
- 기관지 내시경 강의다.
- 흉수 강의의 정확히 하기도 한다.
- 일정 변경이 잦고, 취소되거 대체 과제로 전환되기도 한다.

11:00~12:30 약물 알레르기 + 알레르기 증례, 피부반응검사 실습 — 우성대 교수님

이 시간은 강의 하나 듣고 끝나는 게 아니라, 피부반응검사(SPT)를 실제로 하고 그걸 기본으로 사진 분석 과제 1개 + 약물 알레르기 증례 과제 1개를 만드는 시간이다.
SPT + 알레르기 과제 2개 생산 시간

핵심 정리
- 자(퀸타이드) 기준기준.
- 사진 찍는 것보다 생점 시간 나오게 찍고 분석해서 전제로 제출한다.
- 약물 알레르기는 증상 하나의 단신 문제, 문장 연산물한단, 치료적에에 대해 에표드 준다.
- 과제 2개를 다음주 수요일까지 제출한다.
- 흉수 시간 이상에 흉수 강의는 그냥 강의 1개 이내.
- 흉수 설명보단 시간이 모고 정리는 비교적 쉬운 편이다.

준비 / 운영 포인트
- 조장 인계에는 SPT 사이클 수업 1주일 전에 생기하는 일이 있음
- 사진은 본인 잘 + 해설문이 같이 나오게 찍는 게 중요
- 약물 알레르기 증례는 단순 문제, 문장 연산물한단, 치료적에 4축으로 정리하면 됨
- 인계장 조개 이한기 맡고 등수도 후한 편으로 보시임

15:30~18:00 대면 실습 예비이 피드백 — 이소영 교수님

이 시간은 호흡기 치료를 평가하는 시간이 아니라, 짧은 아이스브레이킹(좋아하는 것·잘한 것·좋았던 일) 후에 팀별토트를 공유하고 서로 피드백하는 성찰 수업이다. 분위기는 인재 표현 그대로 "청천지옥/청천광옥" 쪽에 가깝다.
청천 라운드 + 팀별토트 공유 시간

핵심 정리
- 정해에서 0.5점 정도 이미 서기고 그 자리에서 발표하고 서로 피드백한다.
- 좋았던 일(잘한 것/좋았던 일) 등에 대해 간단하게 말하는 시간이 있다.
- 서로 피드백하는 시간이라 길어 질 것 같다.

금요일

기관지내시경 보통 맞추고 조용히 참관하는 시간이라 contamination 주의
천식/COPD 강의는 하스기 접고 실제로 COPD 30분 정도만 말할 가능성이 큼
오가노이드/실험실 참관은 공요일에서 빼고 수요일 강의으로 통합
병동정리기록지 피드백은 1:1로 짧게 환자 파리정보고 질문받는 시간

시간 변동 기관지경실 — 박동일 교수님

기관지경실은 적극적으로 할 게아 하는 시간이라기보다, 정해진 자리에서 조용히 참관하는 시간이다. 들어가서 복장 맞추고 기다리다가 시술을 조용히 보면 된다.

핵심 정리
- 학생 위치를 표시한 지도 미리지를 같이 보여준다.
- 고글/가운/마스크 착용 후 기관지내 참가한다.
- 혈압는 연결고 가능 후 할 것.
- 위에서 비동기는 실제이어 말이에 한다.
- 전체 부담은 없다.
- contamination 주의

준비 / 운영 포인트
- 흡출기 튜브 양에 바로 손잡 등로 꼭으로 들어가서 간호사에게 참관 갔다고 말하면 된다.
- 고글/가운/마스크를 꼭고 착용한 뒤 의자에서 대기하면 된다.
- 학생은 위에서 비동기나 실제이어 말고 조용히 참관하면 된다.
- 제도는 contamination 때문에 들고 가지 않는 게이 좋다.
- Note가 있었을 수 있지만 수업 자체는 부담이 거의 없다.

기관지경실 학생 대기 위치 지도

11:00~12:30 천식/COPD — 김덕기 교수님

이 슬롯은 이름은 천식/COPD 강의지만, 실제 인계상으로는 하스가 빈뚝되었고 합쳐도 COPD만 짧게 하는 쪽에 가깝다.
하스 짧은 강의 / 실제론 COPD 30분 기반성

핵심 정리
- 김민기 개수 하스의이었다.
- 실제로는 COPD만 30분 정도 하는 듯하다.

준비 / 운영 포인트
- 정보 전달은 유튜브에 보고 하스 기능성을 영두에 둘 것.
- 실제 진료면 COPD 위주 30분 수업으로 생각하면 됨
- 질문은 거의 없었다는 인계가 있음

오가노이드/실험실 참관은 이미 수요일 항목으로 옮겨졌지만 있으므로 금요일 상황에서는 빼기 / 금요일 정리에서는 제외

15:00~18:00 병동환자 문진, 진찰/검과기록지 피드백 → 강다현 교수님

이 시간은 병동정리기록지를 바탕으로 교수님 앞에서 짧은 프리젠을 하고, 내가 환자를 진찰 보고 이해했는지 점검받는 1:1 피드백 시간이다.
병동정리기록지 1:1 피드백

핵심 정리
- 전체 10분 정도 피드백 받는다.
- 물개 노이하는 환자에 대해 정리해서 발표드리라 한다.
- 3일 동안 진찰 환자 설명과는 달라지거나, 환자인인지료에 대한 질문을 하신다.
- 대한 질문 있은 기서 찾아봐줘야 이한 느낌이다.
- 마지막으로 질문 받는다.
- 전날 정리지 과제 제출하고, 당일 프리젠테서 의도대 받는다.
- 프리젠을 드리고 바로 보신을 시작한다.
- B조는 기관지경실 끝나고 바로 이어서 진행하는 듯하다.
- 수정해서 다시 발표 필요는 없다.
- 정보 분리는 잘 되었다는 것이 있음. 프리젠 할수
- 질문은 많지 않고 정리 위주다.
- 중요 항목을 외워 놓아 있으면 자신감에 이득을 미친 정리해가야 함
- 질문이 생겨한 환자가 선정되고을 한다가 수정
- 수정 제안보다는 필요 없다는 인계가 있음

2주차

원문을 빼고, 정돈된 설명과 조사 보강만 남김

수요일

수요일은 회진 브리핑, 예진평가, Mini-CEX가 한날에 몰려 있어서 단순 시간표 정리가 아니라 교수님별 사고방식과 준비법 중심으로 재정렬해야 한다.
정재욱 회진: 3명 × 5분 브리핑 → 핀실 환자 미리 보고 그러도 질문에 답다 답하기
이정은 예진평가: 기록지에 탐정처럼 관찰-판단-확인-재판단 과정을 남기기
정성수 Mini-CEX: 정리보다 환자, 취조보다 개방형 질문, 주호소 꼬리질문

9:00~12:30 회진 참관 — 정재욱 교수님

이건 단순 참관이 아니라, 정재욱 교수님 입원 환자 3명을 미리 보고 아주 짧고 정확하게 브리핑하는 시간이다. 질문 난이도가 높은 편이라 준비를 대충 하면 개일 침든 슬롯이 된다.
정재욱 교수님 병동 회진 브리핑

핵심 장비
- 정재욱 교수님 입원 환자 인당 3명씩 골라서 짧은 브리핑
- 어떤 검査이 찍히 + 어떤 입요 있는 + 현재 치료 + 지금 어떤 상태 + 최근 정보(감자기 변화한 사항과 그 이유)를 총 5줄 정도로 정리
- 전날 환자를 미리 보고 오기를 권하시고 PIEKS 하고 영상도 보고 오길 권하신다
- 질문 난이도가 높다
- 틀린 대답이어도 바로 핀잔하신다
- 교수님 테면서시 포하면 A4 한 장 대략 과제 제출
- 143명용 컴퓨터 두목시 진행
- 조장이 감자 부인면 바로 기는 구조
- 요점은 암기보다 유소하는 일도 있다

14:00 ~ 16:00 CP를 활용한 포트폴리오 → 예진평가(이정은P) — 이정은 교수님

이정은 교수님 예진평가는 예진기록지를 잘 적었는지만 보는 자리가 아니라, 내가 탐정처럼 환자를 관찰하고 의심하고 다시 확인하는 사고 과정을 기록에 담았는지를 보는 시간이다.
이정은 교수님 예진평가

핵심 장비
- 예진기록지 이리 적어두고, 환자 설명을 예진기록지 읽으면서 진행
- P/E에서 V/S를 꼭 체크하고 해상
- 중상이 왜 생겼는지 끝까지 추적하는 과정을 중요하게 봄
- 환자가 상황, 증상, 환경, 과거력, 복용약 바탕으로 왜 이런 증상을 보이는지 재현, 판는 사고과정을 선호
- 환자의 표현 방식대로가 아니라, 학교 대면에서 배우는 고급 영교와 실제 근방 결과가 담긴 기록을 원함
- 강형민기를 요리학교로 narrowing 하는 과정과 추가로 확대를 할려져 이준범을 제시하는 능력을 중요하게 봄
- 일단 기본 상태 보고 이준범 보고서는 개별적 활동이 아닌 이준범 수업으로 이어지 세분화해 분기별 보장
- 요즘 시험 보면 한 번의 결론이 아니라 여러 가능성을 놓고 비교하는 문제가 많음
- 한두 단어 차이로 의심하거나 결론하는 식의 사고가 위험하다고 강조하고 있음
- 환자를 과거에 있었던 일부만 보는 것이 아니라 지금 눈앞에 있는 것을 전체 맥락 안에 놓고 해석해야 함
- 수술한 본은 언제 했는지도 꼭 묻기
- 처방 CC에서는 증상 경험인, 구체적 약물(aspirin, 항혈소판제) 확인
- 출혈 CC에서는 onset, character, 약물인지 중요
- 환자 말만 믿지 말고 필요하면 검査
- 진단명만 동동 찍진만 말고 왜 붙었는지 설명
- 비타민B12 하고 엽산이 자주드러난 진단
- 인공관절 1~2일 내 환자 있었고, 당장 환자가 아닐 수도 있음
- 진단명이 안 나온 환자도 결절 수 있음
- 개별형 질문
- 주호소 중심이 깊은 꼬리질문
- PPI와 라로
- 환자가 자유롭게 이야기하게 만드는 분위기
- 진단명이 불명확해도 reasoning을 이어가는 태도

준비 / 준면 포인트
- 질기 없게 말고 환자와 대화해 집중
- 시험기준은 동료 평가 참조로 출제될 수 있음
- 인용이나 논문이름이 맡고 자주드러나 헤어져 하기
- 진단명 확진 전 환자는 나중 수 있음

조사 / 보충 내용
- 출혈고민(위식장소 일종 변동, 치세에 따른 약물상태, 근성 약물 유발 요인
- 처방: 출혈 경향성, aspirin/항혈소판제 등 구체적 약물, 위식장소관 동장
- 출혈: onset, character, 약물 이력, 심장성 vs 혈관 구분 질문
- 수술력 있는 환자: 언제 수술했는지, 수술 이후 경과

월요일

사용자 지린 건슬: 이거는 수요일에 정성수 교수님이랑 진행해. 월요일에는 이거 X. / 이번 사용자 정리해서는 월요일 mini CEX를 제외하고, 수요일 정성수 교수님 진행으로 준리

15:00~16:00 폐합 — 김소윤 교수님

그냥 판하게 한는 수업으로 보면 됨다. 과제나 시험은 없고 내용 설명 중심.
Easy lecture

핵심 장비
- 폐합 시험 없고 그냥 수업
- 유작선은 대략 강의는 30분 정도
- 부정 등 학업 관련 문제는 중간 중심 준례
- 준리기는 좋다라 부정 없음

화요일

9:00~10:00 CXR — 정재욱 교수님

2주차 핵심있 CXR은 1주차의 질문답변 수업이 아니라 실제 발표 시간이다. 지자 기준에 맞고 있던 환자를 중 판독할 만한 환자 3명을 골라 PPT를 만들고, 판독 논리를 짧고 정확하게 설명하는 것이 핵심이다.
정재욱 교수님 2주차 CXR 발표

10:30~11:30 폐렴 — 이은스 교수님

폐렴 관리는 요즘 ILD와 헷갈 1시간 안쪽으로 진행되는 중 수업이다. 노트북으로 찾아보면서 답해도 되는 분위기라 비교적 부담이 적다.

핵심 장비
- 중이고 ILD랑 3개 묶음서 1시간
- 노트북과 찾아보고 답변해도 됨

14:00~15:30 ILD 강의 → 강다원 교수님(26년~) — 김옥화 교수님 or 이은스 교수님

26년 기준으로는 강다원 교수님 쪽으로 넘어간 흐름으로 보이고, 전반적으로는 그냥 듣는 수업에 가까운 편이다.

핵심 장비
- 이게는 강다원 교수님이 하시는 듯
- 별다 없는 유하다

17:00~18:00 임상추론평가 — 정성수 교수님

이 시간은 보고서를 그냥 제출하는 시간이 아니라, 정성수 교수님이 임상추론평가 보고서에서 무엇을 중요하게 보는지 코멘트하고 1명 정도의 사례를 깊게 분석보는 피드백 시간에 가깝다.
정성수 교수님 임상추론평가 코멘트 시간

핵심 장비
- 임상추론평가 보고서에 대한 코멘트를 주시는 시간이 중
- 정리보단 진단, 추론이 가능한가를 핵심을 잡아 줌
- history, physical examination을 중요하게 생각하심
- 문진 시험은 병원력 작성 중요 때 기준으로 서술함으로 작성
- 1명 정도 정해지면 1명 끝내 기간 피드백하심
- CC를 공동이 자세하게 묻고들고 P/E도 시폐리랑 각각 자세히 물음
- Assessment는 3개 적음
- 감사 받이 병명정확성 신체진찰만으로 질환을 추론해나가는 연습에 기반해 보임
- 소생술이상주 등 다 생략없이 질문이는 경향이 있어, 정성수 교수님 성스런 피드백을 초안은 이보다 약간 더 엄격해도 됨
- 단순 general disease essay처럼 서만 안 되고, 반드시 이 환자에게서 나온 단서와 연결해야 함
- 전문가급 3개를 세우더라도 1순위 가설이 왜 제일 설득력 있는지는 더 분명히 보여줘야 함

목요일

9:00~10:00 총수 강의 — 박동일 교수님

박동일 교수님 총수 강의는 실제 진행되기도 하지만, 시술 일정 태문에 레포트 대체로 바뀌는 경우가 자주 있다.

핵심 장비
- 수업까지 / 레포트로 대체

13:30~15:30 중환자실 증례발표 — 이송이 교수님

이건 조 전체가 한 환자를 같이 준비하는 형 발표이고, 발표자와 질문에 잘 답한 조원에게 추가점 기회가 있는 슬롯이다. 단순 발표보다 ABGA/CXR/ventilator 판리까지 묻는 실전형 피드백 시간에 가깝다.
이송이 교수님 ICU 케이스 발표

핵심 장비
- 발표자 가산점
- 전체 요약이 먼저 온세에 케이스 발표
- 교수님 질문에 잘 답했면 추가 가산점
- 발표자은 질문에 단한 사람을 세운다는 요소이 있었다
- 자신이 맡은 부분을 아니라 다른 조원 파트도 대체로 알고 있어야 추가점 기회가 있다
- 케이스 정리는 질문 순이이고 10장 내외 + 전부 2장
- 교수님은 환자이도를 한 장씩 요점의 보면서 질문한다
- ABGA, CXR, ventilation 관련 내용이 특히 중요하다

준비 / 준면 포인트
- 본인 관련 파트를 조원 모두 공유
- ABGA/ventilator 파트는 전원 파스 핵심 개념 숙지
- 용어이해 필요하다
- 자기 파트 외 조원 파트도 대강 아는 상태로 질문 대비
- ventilator 관련 내용은 양쪽이 서로 같은 표현과만 중주간-기대한기 비교 참고
- PI 5~2명
- 영상/problem/A&P 2명
- hospital course/ABGA/ventilator 2~3명
- review + 발표 1명

질문 / 예시 포인트
- CURB-65 이유
- 항생제 변경 이유
- ABGA 분석
- CXR 해석
- ventilator 설정/변경 이유
- NIV 단점
- Chest AP 단점
- high flow vs low flow
- PEEP 설정 이유
- mechanical ventilator 사용 이유
- septic shock에서 왜이 하는 것(lactic acid)
- cardiac enzyme 올라갔는데 PCI 해야 하는가(type 2 MI 아부)
- CVL 삽입 위치 확인 이유
- Chest AP가 왜 중요한 이유
- Chest AP에서 무엇이는 line/tube 확인
- DD 4가지를 이해
- CRRT 단한 이유시킬 "왜 필요한 치료를 실제로 언 했는지"

15:30~18:00 임상윤리 토의 — 문재영 교수님

형식상 임상윤리 토의지만, 최근에는 최근 이슈 2가지 토론보다 PK 시기에 무엇을 생각하고 결정해야 할지에 대한 교수님 중심 질의응답으로 더 기울어졌다고 보는 게 옳다.
문재영 교수님 (Google Meet) / 최근엔 Q&A형

핵심 장비
- 노트북으로 google meet 진행
- 최근에 이슈인 주제로 2가지 골라서 진행
- 과제는 수업 노트북 제출로 1명
- 계획 최근에는 PK보다 왜 무엇을 생각하고 결정해야 할지에 대한 교수님려의 질의응답으로 변경
- 과제도 꼭은 관련자 아니면 다른 주제로 주시서 읽어 달라는 것

준비 / 준면 포인트
- 노트북 권장
- 이메일로 주제/생각/이해됐 정리 던져 보내는 흐름 유지
- 최근엔 토론보다 교수님 질문에 답하는 형식일 수 있음
- 과제는 대체로 A4 1장 선호

금요일

기준시간은 원칙이라 1주차에 이미 시행됐으므로 2주차 금요일에서는 제거

원작수인 준례로는는 월요일 배양 공의 에 같이 진행된 것으로 처리 / 2주차 월요일 배양 - 김소윤 교수님

15:00~18:00 병동 경과 기록지 피드백 — 김윤주 교수님

1주차보다 훨씬 강도가 높고, SOAP 전 항목을 근거까지 포함해 세세하게 설명해야 하는 심화 피드백 시간이다.
김윤주 교수님 고강도 경과기록지 피드백

핵심 장비
- 1주차보다 훨씬 강도 높음
- 모든 문장을 세세히 보이면서고 인당 20분 정도 피드백
- 보통은 1~2분 안 언로하니 길어지도 크게 문제 생지는 않음
- 이유는 한가지임
- 꼼꼼 등재 X 요 경향적 하로 진행
- 용어에 따른 어떤 걸 진행해야하지, 진단은 뭘로 했는지, 치료를 어떻게 하면 좋을지 질문을 계속 함
- SOAP 순서로 발표하되 A에서 어떤 진단을 붙었는지 명확히 설명해야 함
- 진단을 리뷰는 근거가 명확해야 하고 불명료한 것은 날려 있는 게 정교
- 기준 명세상이도 물어보심

준비 / 준면 포인트
- 환자 조장이 중 임크 준비 및 전달
- 간호사 나눠서 참여하는 구조
- EMR과 엑셀에서 읽기 보고서로 환자 전체 경과를 알고 가야 함
- 질문이 꼬리에 꼬리를 무는 스타일이라 준비가 중요